

养老院护理员工基础医疗知识

一、人体基础解剖与生理学

（一）人体主要器官及系统基本结构和功能

- 心血管系统：**心脏是循环系统的核心，犹如一个强大的泵，通过有节律的收缩和舒张，推动血液在血管中流动。血管分为动脉、静脉和毛细血管，动脉将富含氧气和营养物质的血液从心脏输送到全身各组织器官；静脉则把组织器官代谢产生的二氧化碳和废物带回心脏；毛细血管是血液与组织细胞进行物质交换的场所。了解心血管系统的正常运作，有助于护理员工观察老人是否存在血液循环异常，如手脚冰凉、皮肤苍白等可能暗示心血管问题的症状。
- 呼吸系统：**由呼吸道和肺组成。呼吸道包括鼻腔、咽、喉、气管和支气管，是气体进出肺的通道，具有温暖、湿润和清洁空气的作用。肺是气体交换的主要器官，通过肺泡与血液之间的气体交换，实现氧气的吸入和二氧化碳的排出。护理员工需留意老人呼吸频率、节律和深度的变化，异常情况可能提示呼吸系统疾病。
- 消化系统：**从口腔开始，经咽、食管、胃、小肠、大肠至肛门，是一个连续的管道系统。消化系统的主要功能是消化食物和吸收营养物质，同时将食物残渣排出体外。各消化器官协同工作，口腔进行初步咀嚼和唾液消化，胃通过胃酸和消化酶进一步分解食物，小肠是吸收营养物质的主要场所，大肠则主要负责水分吸收和形成粪便。关注老人的消化功能，如食欲、排便情况等，能及时发现消化系统问题。

（二）老年人体质特点及生理变化

随着年龄增长，老年人的身体机能逐渐衰退。在心血管方面，心脏收缩力减弱，血管弹性降低，易出现高血压、冠心病等疾病；呼吸系统方面，肺活量减小，呼吸功能下降，容易患呼吸道感染；消化系统方面，胃肠蠕动减慢，消化液分泌减少，导致消化不良、便秘等问题；骨骼肌肉系统方面，骨密度降低，肌肉萎缩，关节灵活性下降，增加骨折和跌倒的风险；神经系统方面，反应速度变慢，记忆力减退，可能出现认知障碍。护理员工要了解这些变化，在照顾老人时给予针对性的关怀和护理。

二、常见老年疾病知识

（一）老年常见疾病基本病因、症状及护理要点

- 高血压：**病因复杂，与遗传、年龄、生活方式（如高盐饮食、缺乏运动、长期精神紧张等）密切相关。症状通常不明显，部分患者可能出现头痛、头晕、心悸等症状。护理要点包括定期测量血压，督促老人按时服药，控制饮食中盐的摄入，鼓励适量运动，保持情绪稳定。
- 糖尿病：**主要由于胰岛素分泌不足或作用缺陷引起。典型症状为“三多一少”，即多饮、多食、多尿和体重减轻。护理时要注意监测血糖，合理安排饮食，控制碳水化合物、脂肪和蛋白质的摄入量，指导老人进行适当的运动，按时注射胰岛素或服用降糖药，并注意预防低血糖的发生。
- 骨质疏松：**以骨量减少、骨组织微结构破坏为特征，导致骨脆性增加，易发生骨折。常见于老年女性，与雌激素水平下降、钙摄入不足、缺乏运动等因素有关。症状可能有腰背疼痛、身高缩短、驼背等。护理上要为老人提供富含钙和维生素D的食物，鼓励老人适当晒太阳，进行适量的户外活动，防止跌倒，预防骨折。
- 慢性阻塞性肺疾病（COPD）：**主要由长期吸烟、空气污染等因素引起。表现为慢性咳嗽、咳痰、气短或呼吸困难等。护理要点包括劝导老人戒烟，保持室内空气清新，指导老人进行呼吸功能锻炼，如缩唇呼吸、腹式呼吸等，在病情急性发作时及时送医治疗。
- 中风：**又称脑卒中，包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中。高血压、高血脂、糖尿病、吸烟等是主要危险因素。症状突然出现，如一侧肢体无力、麻木，言语不清，口角歪斜等。护理时要密切观察老人的生命体征和病情变化，保持呼吸道通畅，协助老人进行康复训练，预防并发症的发生。

6. **认知障碍（如阿尔茨海默病）**：病因尚不明确，可能与遗传、环境、生活方式等多种因素有关。主要表现为记忆力减退、认知功能下降、行为异常等。护理员工需要给予老人充分的耐心和理解，为老人创造安全、舒适的生活环境，协助老人进行日常生活活动，通过记忆训练、认知刺激等活动延缓病情进展。

（二）疾病预防和日常护理措施

预防老年疾病的关键在于健康的生活方式。护理员工应鼓励老人保持均衡饮食，多吃蔬菜水果、全谷类食物，减少高脂肪、高糖和高盐食物的摄入；适量运动，如散步、太极拳等，增强体质；戒烟限酒；保持良好的心态，避免长期精神紧张和焦虑。在日常护理中，要根据老人的疾病情况，提供个性化的护理服务，如协助行动不便的老人进行日常活动，定期为老人翻身、拍背，预防压疮和肺部感染等并发症。

三、基本生命体征监测

（一）测量和记录体温、脉搏、呼吸、血压等基本生命体征

1. **体温测量**：常用的测量方法有腋温、口温和肛温测量。腋温测量较为常用，将体温计水银端夹于腋窝深处，10分钟后读数。正常腋温为 36 - 37℃。测量时要注意擦干腋窝汗水，确保体温计与皮肤紧密接触。
2. **脉搏测量**：通常选择桡动脉进行测量。将食指、中指和无名指并拢，轻压于桡动脉处，感知脉搏的跳动。计数 1 分钟的脉搏次数。正常脉搏为 60 - 100 次/分钟。测量时要注意保持安静，避免在老人运动、情绪激动后立即测量。
3. **呼吸测量**：观察老人胸部或腹部的起伏，一呼一吸为一次呼吸。计数 1 分钟的呼吸次数。正常呼吸频率为 16 - 20 次/分钟。测量时不要让老人察觉，避免因紧张而影响呼吸频率。
4. **血压测量**：可使用水银血压计或电子血压计。让老人安静休息 5 - 10 分钟后，坐在椅子上，手臂平放于桌面，与心脏保持同一水平。将血压计袖带缠于上臂，听诊器置于肱动脉搏动处，充气至动脉搏动消失后再升高 20 - 30mmHg，然后缓慢放气，听取柯氏音，记录收缩压和舒张压。正常血压收缩压为 90 - 139mmHg，舒张压为 60 - 89mmHg。

（二）识别异常指标，及时报告

护理员工要熟悉正常生命体征的范围，当发现老人的生命体征出现异常时，如体温过高或过低、脉搏过快或过慢、呼吸急促或困难、血压过高或过低等，应及时报告医生或护士，以便及时采取相应的治疗措施。同时，要记录异常生命体征的具体数值和时间，为医生的诊断和治疗提供依据。

四、用药知识

（一）常见药物的分类、作用和常见副作用

1. **降压药**：如利尿剂、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）等。利尿剂通过促进排尿，减少血容量来降低血压，常见副作用有低钾血症、口干等；β受体阻滞剂可减慢心率、降低心肌收缩力，副作用可能有心动过缓、乏力等；钙通道阻滞剂能扩张血管，降低血压，常见副作用有面部潮红、头痛等；ACEI 可抑制血管紧张素转换酶，减少血管紧张素Ⅱ的生成，从而降低血压，副作用可能有咳嗽、高血钾等。
2. **降糖药**：包括磺脲类、双胍类、α-葡萄糖苷酶抑制剂等。磺脲类促进胰岛素分泌，降低血糖，副作用可能有低血糖、体重增加等；双胍类主要减少肝脏葡萄糖的输出，改善外周胰岛素抵抗，常见副作用有胃肠道反应；α-葡萄糖苷酶抑制剂延缓碳水化合物在肠道的吸收，降低餐后血糖，副作用可能有腹胀、排气增多等。
3. **抗生素**：用于治疗细菌感染。不同种类的抗生素作用机制不同，如青霉素类通过抑制细菌细胞壁的合成来发挥抗菌作用，头孢菌素类具有广谱抗菌活性。抗生素的常见副作用有过敏反应、胃肠道不适、肝肾功能损害等。

（二）正确的给药方法和注意事项

1. **口服给药**：要确保老人正确服用药物，对于吞咽困难的老人，可将药物研碎后混入食物中服用，但要注意有些药物不能研碎，如肠溶片、缓释片等。指导老人用适量温水送服药物，避免干吞，以免药物黏附在食管上引起损伤。
2. **注射给药**：包括皮下注射、肌肉注射和静脉注射。护理员工要掌握正确的注射方法，严格遵守无菌操作原则，选择合适的注射部位。如皮下注射常选择上臂三角肌下缘、腹部等部位；肌肉注射常选择臀大肌、臀中肌等部位；静脉注射要选择粗直、弹性好的血管。注射时要注意观察老人的反应，如有不适及时处理。
3. **外用给药**：如涂抹药膏、滴眼药水等。涂抹药膏时要注意清洁皮肤，将药膏均匀涂抹在患处；滴眼药水时要让老人仰卧或坐位，头向后仰，眼睛向上看，用手指轻轻拉开下眼睑，将眼药水滴入结膜囊内，避免眼药水瓶口接触眼睛，防止污染。

（三）药物管理和安全用药原则

护理员工要协助老人妥善保管药物，将药物放在干燥、阴凉、儿童不易拿到的地方。按照医生的嘱咐，按时、按量给老人服药，不得擅自增减药量或停药。注意药物的有效期，过期药物要及时处理。在老人服用多种药物时，要注意药物之间的相互作用，避免不良反应的发生。同时，要观察老人服药后的反应，如出现不适症状及时报告医生。

五、急救基础知识

（一）掌握心肺复苏（CPR）基本技能

心肺复苏是针对呼吸心跳骤停的患者所采取的急救措施。操作步骤包括：首先判断患者意识，轻拍患者肩膀并大声呼喊，如无反应，立即呼叫急救人员并获取自动体外除颤器（AED）。然后检查患者呼吸，观察胸部起伏，如无呼吸或仅有喘息，立即进行胸外按压。将患者仰卧于硬质平面上，施救者跪在患者一侧，双手重叠，掌根置于两乳头连线中点，垂直向下按压，深度至少 5 厘米，频率至少 100 次/分钟。每按压 30 次，进行 2 次人工呼吸。人工呼吸时，要捏住患者鼻子，用嘴包住患者的嘴，缓慢吹气，观察患者胸部起伏。持续进行 5 个循环的 CPR 后，再次评估患者的意识和呼吸，如无恢复，继续进行 CPR，直到急救人员到达。

（二）处理窒息、跌倒、出血、中暑等突发状况的基本方法

1. **窒息**：如果老人发生窒息，表现为突然呼吸困难、面色青紫等，护理员工要立即采用海姆立克急救法。对于清醒的老人，站在老人背后，用双臂环绕老人腰部，一手握拳，拳眼对准老人上腹部（肚脐以上两横指），另一手握住拳头，快速向上冲击老人上腹部，重复操作，直至异物排出。对于昏迷的老人，将老人平卧，施救者骑跨在老人髋部两侧，双手重叠，掌根置于老人上腹部，快速向前下方冲击，直至异物排出。
2. **跌倒**：老人跌倒后，不要急于扶起，要先判断老人的意识、有无外伤和疼痛部位。如老人意识清醒，询问老人是否有不适，协助老人慢慢起身，检查身体有无擦伤、骨折等情况。如有骨折，不要随意搬动老人，应固定受伤部位，等待专业人员救援。如老人意识不清，立即呼叫急救人员，并检查老人的呼吸、心跳，如无呼吸心跳，立即进行心肺复苏。
3. **出血**：根据出血部位和出血量采取不同的止血方法。如为轻微擦伤出血，可用干净的纱布或毛巾按压伤口止血；如为动脉出血，出血速度快、量大，要在近心端用止血带或绷带加压包扎止血，但要注意每隔一段时间放松一次，防止肢体缺血坏死；如为静脉出血，可在远心端进行压迫止血。同时，要尽快将老人送往医院进行进一步处理。
4. **中暑**：在高温环境下，老人出现头晕、头痛、口渴、多汗、乏力等症状时，可能是先兆中暑。此时应立即将老人转移到阴凉通风处，解开衣服，用湿毛巾擦拭身体降温，补充含盐分的清凉饮料。如老人出现面色苍白、血压下降、脉搏细弱等症状，可能是重度中暑，要迅速将老人送往医院抢救，在送医途中要注意保持老人呼吸道通畅，进行物理降温。

（三）迅速识别和应对紧急医疗情况

护理员工要具备敏锐的观察力，能够迅速识别老人出现的紧急医疗情况，如突发胸痛、呼吸困难、剧烈头痛、意识障碍等。一旦发现这些情况，要立即呼叫急救人员，并在等待急救人员到来的过程中，根据所学知识进行初步的急救处理，如让老人保持安静、平卧，解开衣领腰带，保持呼吸道通畅等。

六、无菌操作与感染控制

（一）了解基本的无菌操作流程，防止交叉感染

无菌操作是指在无菌环境下进行的操作，目的是防止微生物进入人体或物体，避免感染的发生。在进行无菌操作前，护理员工要洗手、戴口罩、帽子，穿戴无菌手套和无菌隔离衣。操作过程中，要保持无菌区域不被污染，如避免无菌物品接触有菌物品，不要跨越无菌区等。操作结束后，要正确处理无菌物品和污染物，防止交叉感染。例如，在进行注射操作时，要严格遵守无菌原则，对注射部位进行消毒，确保注射器、针头等物品无菌。

（二）知道如何正确使用消毒和防护设备

消毒设备包括紫外线灯、消毒柜等。紫外线灯可用于空气和物体表面的消毒，使用时要注意按照说明书的要求控制照射时间和距离，避免紫外线对人体造成伤害。消毒柜用于对医疗器械、餐具等进行消毒，要正确放置物品，确保消毒效果。防护设备如口罩、手套、隔离衣等，护理员工要根据不同的操作场景选择合适的防护设备。如在可能接触血液、体液的操作时，要戴手套、穿隔离衣；在照顾患有呼吸道传染病的老人时，要戴口罩，防止病原体传播。

七、营养与饮食护理知识

（一）了解老年人营养需求和特殊饮食注意事项

老年人的身体机能下降，对营养的需求也有所不同。他们需要充足的蛋白质来维持肌肉质量和免疫功能，可选择瘦肉、鱼类、豆类、蛋类等优质蛋白质食物；碳水化合物应选择复杂碳水化合物，如全谷类、薯类等，避免过多摄入简单碳水化合物，如白糖、糖果等；脂肪要选择健康的脂肪，如不饱和脂肪酸，减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸的摄入，可多吃鱼类、坚果等食物。同时，老年人对钙、维生素 D、铁、锌等营养素的需求增加，要注意补充。在特殊饮食方面，如有高血压的老人要控制盐的摄入，每天不超过 5 克；有糖尿病的老人要控制碳水化合物的摄入量，遵循定时定量的原则；有吞咽困难的老人要选择软食、半流食或糊状食物，避免食物呛入气管。

（二）能协助制定或执行合理的饮食计划

护理员工要根据老人的身体状况、疾病情况和饮食习惯，协助医生或营养师制定合理的饮食计划。饮食计划要包括食物的种类、数量、进食时间和方式等。在执行饮食计划过程中，要关注老人的进食情况，鼓励老人按时进食，保证摄入足够的营养物质。对于食欲不振的老人，要采取措施提高老人的食欲，如调整食物的色香味、增加进食次数等。同时，要注意饮食卫生，保证食物新鲜、清洁，防止食物中毒的发生。

八、心理健康基础

（一）了解老年人常见心理问题（如抑郁、孤独感等）

老年人由于身体机能衰退、社会角色转变、亲友离世等因素，容易出现各种心理问题。抑郁是老年人常见的心理障碍之一，表现为情绪低落、兴趣减退、自责自罪、睡眠障碍等。孤独感也是老年人普遍存在的心理问题，他们可能因为子女不在身边、社交活动减少等原因感到孤独无助。此外，老年人还可能出现焦虑、恐惧、猜疑等心理问题。护理员工要关注老人的心理变化，及时发现这些心理问题。

（二）掌握基本的心理疏导技巧

当发现老人出现心理问题时，护理员工要运用基本的心理疏导技巧给予帮助。要与老人建立良好的沟通关系，耐心倾听老人的心声，让老人感受到被理解和尊重。鼓励老人表达自己的情感，分享自己的经历和感受。可以通过组织社交活动、开展兴趣小组等方式，增加老人的社交互动，缓解孤独感。对于抑郁的老人，要给予更多的关心和陪伴，鼓励老人积极面对生活，必要时建议老人寻求专业心理医生的帮助。

九、康复护理基础

（一）了解辅助活动、康复训练的基本原则

辅助活动和康复训练的目的是帮助老人恢复身体功能，提高生活质量。基本原则包括个体化原则，根据老人的身体状况、疾病情况和康复需求制定个性化的康复方案；循序渐进原则，康复训练的强度和难度要逐渐增加，避免过度训练造成损伤；全面性原则，康复训练要综合考虑老人的身体各个方面，包括肌肉力量、关节活动度、平衡能力等；长期性原则，康复是一个长期的过程，需要老人坚持进行训练。

（二）协助老人进行适当的身体活动和功能训练

护理员工要根据康复方案，协助老人进行适当的身体活动和功能训练。如对于行动不便的老人，可以协助他们进行床上的肢体活动，如屈伸关节、翻身等；对于有一定运动能力的老人，可以陪伴他们进行散步、太极拳等户外活动。在训练过程中，要注意保护老人的安全，避免老人跌倒受伤。同时，要鼓励老人积极参与训练，增强他们康复的信心。

十、法律法规与伦理知识

（一）熟悉养老护理相关的法律法规

护理员工要熟悉与养老护理相关的法律法规，如《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等。这些法律法规明确了老人的权益和养老机构的责任，护理员工要依法履行自己的职责，保障老人的合法权益。例如，老人有获得生活照料、医疗保健、康复护理等服务的权利，护理员工要按照规定为老人提供相应的服务。

（二）尊重老人权益，遵守职业道德

尊重老人是养老护理工作的基本伦理要求。护理员工要尊重老人的人格尊严、隐私和个人选择，不歧视、不虐待老人。要关心老人的生活和心理需求，为老人提供温暖、贴心的服务。遵守职业道德，保守老人的秘密，不泄露老人的个人信息。在工作中要保持诚实守信、敬业奉献的精神，不断提高自己的业务水平和服务质量，为老人创造一个安全、舒适、和谐的养老环境。

通过掌握以上这些基础医疗知识，养老院护理员工能够更加专业、全面地照顾老年人，为老人的健康和 safety 提供有力保障，提高老人的生活质量。